

TOP-KT-028 - Archivering

▼ Versiegeschiedenis			
Versie	Datum	Status	Wijziging
0.1	6 May 2026	Concept	Concept versie topic 28 opgesteld

Beschrijving

De Koppeltaalvoorziening slaat (patiëntgerelateerde) gegevens op binnen een Koppeltaal-domein. Om aan wettelijke en contractuele bewaartermijnen te kunnen voldoen, moet deze gegevens kunnen worden gearchiveerd en verwijderd op een gecontroleerde en auditeerbare manier. Wanneer deze gegevens worden verwijderd, is het essentieel dat de applicaties die (mogelijk) gebruik maken van de gegevens hiervan op de hoogte worden gesteld voordat dit gebeurt. Dit geeft die applicaties de kans om hierop te acteren en mogelijk deze gegevens op te slaan.

De gekozen oplossingsrichting beheert het archiverings proces via een lifecycle op de `Patient` resource, vastgelegd met `meta.tag` en ondersteund door immutable `AuditEvent` -registraties. Dit model maakt het proces transparant voor doelapplicaties, biedt ruimte voor een overgangperiode en een tijdelijke opschorting van het proces. Definitieve verwijderings (`$purge`) vindt pas plaats nadat betrokken partijen de gelegenheid hebben gehad data veilig te stellen, zonder dat de regie van het ECD als dossierhouder wordt overgenomen.

Overwegingen

Scope van archivering

In scope van dit topic zijn de cliëntgerelateerde FHIR-resources binnen de client context en de lifecycle daarvan, inclusief bewaartermijnen, overgang naar archivering, notificatie aan betrokken partijen en onomkeerbare verwijdering op patiëntniveau. Daarnaast worden de bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden binnen het Koppeltaal-stelsel vastgelegd.

Buiten scope van dit topic zijn niet cliënt-specifieke resources of resources die geen onderdeel vormen van de uitwisselingsdata, inclusief `Practitioner` -resources en

operationele of configuratieve resources zoals `Subscription`, `Endpoint` en `Device`. Ook de langdurige archivering van medische dossiers binnen het ECD, functionele of organisatorische processen buiten Koppeltaal en technische of infrastructurele implementatiedetails vallen buiten de scope van deze standaard.

Archiverings proces en lifecycle

Archivering is geen enkelvoudige actie, maar een proces met meerdere fasen waarin data van actief naar gearhiveerd en uiteindelijk naar definitief verwijderd gaat. Een expliciete lifecycle is noodzakelijk om dit proces transparant, auditeerbaar en beheersbaar te maken voor alle betrokken partijen binnen het Koppeltaal-domein.

Archivering binnen Koppeltaal vindt in-place plaats: data blijft in de FHIR store en wordt niet fysiek verplaatst. De archiveringsstatus wordt vastgelegd via lifecycle-tags op de Patient resource. FHIR security labels worden gebruikt voor dataclassificatie en toegangsregimes, niet voor het modelleren van lifecycle-statussen.

Er is gekozen voor een lifecycle-model op basis van FHIR `meta.tag` op de Patient resource, aangevuld met immutable `AuditEvent`-registraties. Deze keuze sluit aan bij FHIR-principes (state vs. events), voorkomt overbelasting van het stelsel met transactielogica en maakt het proces juridisch aantoonbaar. Alternatieven zoals directe verwijdering of Task-gebaseerde coördinatie zijn overwogen, maar bieden onvoldoende transparantie of introduceren disproportionele complexiteit.

Stappen in de lifecycle (input voor flowdiagram)

De archiveringsflow bestaat uit de volgende functionele stappen (TODO, flow diagram):

1. Actieve patiënt

- Patient is actief en zichtbaar in reguliere zoekresultaten.

2. Start archivering

- `Patient.meta.tag = ARCHIVE_PENDING`
- Archivering proces is gestart op basis van een trigger (zie ...)
- Grace period start.
- AuditEvent: `archive-initiated`.
- Doelapplicaties worden genotificeerd.

3. Grace period

- Doelapplicaties kunnen data veiligstellen.
- Optioneel: noodrem activeren (`ARCHIVE_HOLD`).

4. (Optioneel) Noodrem

- `ARCHIVE_HOLD` actief → proces gepauzeerd.
- AuditEvent: `archive-hold`.
- Na opheffing: AuditEvent `archive-hold-released`.

5. Archivering voltooid

- `Patient.meta.tag = ARCHIVED`
- Data is read-only en niet in reguliere zoekresultaten.
- AuditEvent: `archive-completed`.

6. Voorbereiding definitieve verwijdering

- `Patient.meta.tag = PURGE_PENDING`
- AuditEvent: `purge-initiated`.

7. Definitieve verwijdering

- `$purge` op Patient Compartment.
- AuditEvent: `purge-completed`.
- AuditEvents blijven behouden.

Data classificatie en labels

Binnen het archiveringsproces worden FHIR security labels gebruikt voor de classificatie van data (bijv. persoonsgegevens, logging) en voor het afdwingen van bijbehorende beveiligings- en toegangsregimes. Security labels geven niet de voortgang van het archiverings- of verwijderproces weer. De actuele archiveringsstatus van patiëntdata wordt vastgelegd via een expliciete lifecycle op de Patient resource (bijv. `ARCHIVE_PENDING`, `ARCHIVED`, `PURGE_PENDING`).

Rollen en verantwoordelijkheden

Archivering raakt juridische verantwoordelijkheden. Zonder expliciete rolafbakening ontstaat het risico dat verantwoordelijkheden verschuiven of impliciet bij de Koppeltaalvoorziening worden neergelegd.

De volgende rolverdeling is vastgelegd:

- Koppeltaalvoorziening: verwerker; initieert en faciliteert het archiveringsproces op basis van overeengekomen bewaartermijnen.
- ECD: verwerkingsverantwoordelijke en dossierhouder; verantwoordelijk voor veiligstellen en langdurige bewaring. Het ECD blijft als bronsysteem leidend voor zorginhoudelijke bewaarplichten en kan aanvullende of afwijkende verwijderbesluiten initiëren.
- Doelapplicaties: autonome deelnemers; verantwoordelijk voor eigen data en opvolging van notificaties.

Deze afbakening sluit aan bij AVG- en AORTA-principes en voorkomt scope-creep van het stelsel.

Triggering van archivering

Zonder duidelijke afspraken over de initiatie van archivering op basis van welke triggers, ontstaat onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en timing. Dit is met name kritisch gezien het verschil in bewaartermijnen tussen AVG (Koppeltaalvoorziening) en WGBO (ECD).

Er is gekozen voor een hybride model:

- De Koppeltaalvoorziening initieert archivering automatisch wanneer de AVG-bewaartermijn (2 jaar inactiviteit) is verstreken.
- Het ECD kan archivering of verwijdering initiëren in specifieke situaties, zoals contractbeëindiging of verzoeken van betrokkenen.

De exacte definitie van “laatste activiteit” is bewust niet normatief vastgelegd, omdat dit implementatie- en contextafhankelijk is en sterk varieert per omgeving.

Notificeren van doelapplicaties

Doelapplicaties kunnen patiëntdata bevatten die eerst veiliggesteld moet worden voordat archivering of verwijdering plaatsvindt. Notificatie is daarom essentieel om functionele continuïteit en zorgvuldigheid te borgen.

Er is gekozen voor een verifieerbaar notificatiemechanisme op basis van FHIR

Subscriptions op het `_tag` zoekcriterium. Dit model:

- informeert doelapplicaties tijdig;
- vereist geen expliciete bevestiging (opt-out);
- ondersteunt een grace period;
- minimaliseert coördinatiecomplexiteit.

De Koppeltaalvoorziening is verantwoordelijk voor het verzenden en vastleggen van notificaties, niet voor de acties die doelapplicaties daarna ondernemen.

Grace period en noodrem

Een tijdelijke blokkade (`ARCHIVE_HOLD`) is nodig om uitzonderingssituaties op te vangen zonder een zwaar two-phase-commit-mechanisme verplicht te stellen.

Aantoonbaarheid & compliance

Archivering en verwijdering moeten juridisch aantoonbaar zijn. Zonder audit trail is niet vast te stellen of processen correct en tijdig zijn uitgevoerd.

Er is gekozen voor het vastleggen van alle statusovergangen in immutable `AuditEvent` resources, conform NEN 7513. AuditEvents:

- bevatten geen directe persoonsgegevens;
- overleven de `$purge` ;
- vormen het bewijs voor correcte uitvoering van archivering en verwijdering.

Hiermee wordt voldaan aan eisen vanuit AVG, NEN 7510 en NEN 7513, zonder de operationele FHIR-resources onnodig te belasten.

Verwijderen op patiëntniveau

Vanwege referentiële samenhang tussen FHIR-resources is individuele verwijdering onwerkbaar; patiëntniveau is het enige robuuste granulatieniveau.

Eisen